Piano Emergenza Intraospedaliera Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) nell'Ospedale S. Stefano di Prato

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
09/08/2023	**Referenti gruppo di redazione** Direttore SOS Percorsi Formativi in medicina d'urgenza Ersilia De Curtis SOC DSPO Santo Stefano Dante Mondanelli	Referente SOC Coordinamento maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario Alessio Lubrani **SGQ** Direttore SOSD Programmazione e Monitoraggio Documentazione a Supporto dell'Assistenza Sanitaria Marco Brogi	Direttore SOC DSPO Santo Stefano Maria Teresa Mechi Direttore SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano Simone Magazzini Incarico Professionale di Gestione infermieristica SOS Prato Monica Chiti

Firme all'originale

Gruppo di redazione:

- Filippo Arfaioli, Infermiere, SOC Coordinamento maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario
- Lucia Baroncelli, Infermiere, SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano
- Filippo Becherucci, dirigente medico, SOC Anestesia e Rianimazione Prato
- Patrizia Corazzesi PO Processi Amministrativi Emergenza Urgenza e Maxiemergenza
- Ersilia De Curtis, dirigente medico, SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano - direttore SOS Percorsi Formativi in medicina d'urgenza
- Giorgio Giuliani, dirigente medico, Direttore SOSD Emergenza Territoriale Prato
- Stefano Gori, Infermiere Coordinatore, SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano
- Francesco Ielo, Infermiere, Incarico di Funzione Esperto Strategico Qualità, Monitoraggio e HTA
- Concetta Manzone, Infermiere Coordinatore, SOS Emergenza Territoriale Prato
- Serena Massai, Infermiere, SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano
- Dante Mondanelli, dirigente medico, Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Santo Stefano
- Alessandra Naselli, Infermiere, SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano
- Benedetta Olivieri, Infermiere Coordinatrice AMA
- Stella Squarciotta, dirigente medico, SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano

Supporto Metodologico:
SOSD Programmazione e Monitoraggio Documentazione a Supporto dell'Assistenza Sanitaria

Parole chiave: maxiemergenza, catastrofe, PEIMAF, Pronto Soccorso, NBCRe

Indice

1. Premessa 2
2. Scopo/ Obiettivi 3
3. Campo di applicazione 3
4. Glossario e Definizioni 3
5. Modalità di attivazione del PEIMAF 4
6. Fasi di attivazione del PEIMAF 5
7. Attivazione e gestione maxi emergenza convenzionale 6
7.1. Catena di comando 6
8. Valutazione della massima capacità ricettiva e di trattamento dell'ospedale HCT (Hospital Treatment Capacity) 6
9. Rimodulazione delle aree del PS/DEA in caso di PEIMAF 7
10. Accesso dei Pazienti in caso di maxiemergenza convenzionale 8
11. Attivazione e gestione maxi emergenza non convenzionale (NBCRe) 8
11.1. Catena di comando 8
11.2. Modalità di vestizione e svestizione in caso di Maxiemergenza non convenzionale (NBCRe) 9
11.3. Stanza di decontaminazione 10
11.4. Accesso dei pazienti in caso di maxiemergenza non convenzionale (NBCRe) 10
12. Aree speciali 10
13. Reclutamento personale 10
14. Prolungamento e\o fine dell'emergenza 11
15. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione 11
16. Monitoraggio e controllo 12
17. Strumenti / Registrazioni 12
18. Revisione 12
19. Allegati 12
20. Riferimenti 12
21. Indice revisioni 12
22. Lista di diffusione 13

Copia conforme all'originale

1. Premessa

Per **Piano di Emergenza Intraospedaliera Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF)** si intende quell'insieme di disposizioni organizzative e procedurali che consente ad un ospedale di far fronte ad una maxiemergenza mantenendo uno standard di trattamento dei pazienti paragonabile a quello garantito al paziente singolo.

L'arrivo improvviso e imprevedibile di un elevato numero di pazienti in corso di una maxiemergenza può mettere a dura prova il sistema di emergenza territoriale e la rete dell'emergenza ospedaliera

Un evento catastrofico richiede l'integrazione delle varie componenti dedicate all'assistenza in emergenza pertanto appare necessario seguire, nella gestione delle conseguenze di una maxiemergenza, criteri univoci ed universalmente condivisi in quanto efficaci.

La redazione di un piano contempla l'insieme delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi una maxiemergenza e rappresenta lo strumento che consente di coordinare i soccorsi, a tutela sia delle persone presenti sia dei lavoratori, al fine di mantenere livelli di assistenza efficaci ed efficienti anche in occasione di situazioni di emergenza straordinarie interne od esterne alla struttura ospedaliera. Per i suddetti motivi il piano per il massiccio afflusso di feriti aziendale, di cui il presente documento è il recepimento presso il PO S. Stefano di Prato, si basa sull'utilizzo di poche regole semplici e immediate (metodo SISmax) attraverso le quali è possibile coordinare rapidamente le azioni di tutti gli operatori interessati allo scopo di ottenere la miglior risposta allo stress esercitato da un massiccio afflusso di pazienti sul sistema.

2. Scopo/ Obiettivi

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità operative per garantire la risposta organizzativa e strutturale in caso di eventi particolari che determinino un massiccio ed improvviso afflusso di feriti presso il PO S. Stefano di Prato.
Gli obiettivi da raggiungere sono:

- accettare contemporaneamente un numero di pazienti molto superiore al flusso ordinario di accessi;
- mantenere un livello assistenziale adeguato;
- ottenere una risposta rapida, ben strutturata ed omogenea, predisponendo indicazioni operative per il personale.

3. Campo di applicazione

Il presente documento è applicato da tutto il personale dell'Ospedale S. Stefano di Prato e in particolare dal Dipartimento di Emergenza e Accettazione

4. Glossario e Definizioni

CO: Centrale Operativa
DCA: Direttore attività clinico-assistenziali
DD: Direttore Diagnostica
DEA: dipartimento di emergenza e accettazione
DMPO: Direzione Medica Presidio Ospedaliero
DPI: Dispositivo di protezione individuale
DSSH: Direttore Soccorso Sanitari Ospedalieri, è il medico responsabile del coordinamento dei soccorsi in ospedale (Medico-PS)
NBCRe: Nucleare– Biologico– Chimico – Radiologico – esplosivo
OBI: Osservazione breve intensiva
OSS: Operatore Sociosanitario
PEIMAF: Piano Emergenza Intraospedaliero Massiccio Afflusso Feriti
PS: Pronto Soccorso
RI: Referente Infermieristico
RST: referente della squadra di trasporto
RT: Infermiere Referente di Triage
SOC: Struttura operativa complessa
SOS: Struttura operativa semplice
TSRM: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
TVR: Team di valutazione Rapida
USC: Unità Sanitaria di Crisi. È nominata dal Direttore Generale ed è formata dai membri previsti dalla Delibera Giunta Regione Toscana n. 1390 del 27/12/2004. I ruoli dell'USC, sono specificati nel Documento Aziendale "Piano Aziendale per la gestione degli eventi di Maxiemergenza" – cod. az. DOC.DS.03.
USCZ: Unità Sanitaria di Crisi Zonale. I componenti delle USC zonali sono:

- Direttori/e Sanitario di Presidio/i (DSPO) con funzione di coordinatore USC zonale
- Dirigente Infermieristico di presidio/zona
- Direttore UO del Farmaco di presidio/zona
- Direttore Pronto soccorso di presidio/zona
- Direttore EMS territoriale di zona
- Direttore UO anestesia e rianimazione di presidio/zona
- Direttore/Referente UO prevenzione di zona
- Direttore/Referente area tecnica di zona
- Direttore Zona Distretto
- Direttore SePP zonale

Copia conforme all'originale

I ruoli dell'USC zonale, sono specificati nel Documento Aziendale "Piano Aziendale per la gestione degli eventi di Maxiemergenza" – cod. az. DOC.DS.03. I nominativi dei componenti dell'USC zonale, sono riportati nell'Allegato 1.

5. Modalità di attivazione del PEIMAF

La notizia di un probabile massiccio afflusso di feriti giunge al Pronto Soccorso del PO Santo Stefano attraverso 3 possibilità:

- CO 118, territorialmente competente, per emergenza interna o esterna al Presidio Ospedaliero
- Autopresentazione
- Emergenza interna

Nel caso in cui l'informazione giunga da:

- **CO118 territorialmente competente:** la Centrale Operativa 118 chiama il numero dedicato del PS e viene allertato il Direttore Sanitario Aziendale che attiva l'USC ed eventualmente l'USC zonale;
- **Autopresentazione:** il personale presente al triage informa, senza ritardo, la CO 118 territorialmente competente, la DMPO ed il Coordinatore maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario;
- **Emergenza interna:** l'informazione arriva direttamente al PS per il tramite della DMPO o della CO 118 territorialmente competente che informa il Direttore sanitario Aziendale ed il Coordinatore Maxi Emergenze.

La chiamata di allarme può configurare le seguenti possibilità:

1. **Attivazione preventiva:** nei casi in cui si preveda una potenziale contingenza in grado di sviluppare un evento critico per l'azienda. Ne sono esempio:
   - Previsioni di eventi meteo di particolare importanza
   - Previsione di pandemie/epidemie,
   - Previsione di eventi socio-culturali o ludico-sportivi in grado di determinare un massiccio afflusso di utenza presso una data area nel territorio gestito dall'azienda.

In questa evenienza, la comunicazione preventiva giunge alla DMPO di norma dal servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 territorialmente competente o dalla SOC maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario;

2. **Pre-allertamento:** previsto nei casi in cui CO 118 riceva chiamate che facciano ipotizzare che si stia realizzando un evento critico. Ne sono esempi gli incidenti maggiori a carico di industrie, eventi traumatici che coinvolgono un numero elevato di persone, incidenti all'interno di strutture sanitarie per i quali sia prevedibile una evacuazione, minaccia terroristica, incendi, richieste di supporto per la gestione di eventi critici da parte di altre aziende sanitarie, o qualsiasi altro evento che determini uno squilibrio improvviso ed impattante fra le risorse disponibili e le risorse necessarie

3. **Attivazione definitiva:** segue alla pre-allerta, prevista nei casi in cui sia confermato un massiccio afflusso di pazienti al PS.

Il PEIMAF viene attivato dal Direttore Sanitario Aziendale, previa dichiarazione di Maxiemergenza, per mezzo del coordinatore team, come previsto dal Piano di Maxiemergenza Aziendale.

La CO 118 competente per territorio, oltre ai compiti previsti dal Piano di Maxiemergenza Aziendale, si occupa anche di comunicare ai mezzi di Soccorso l'eventuale variazione dei percorsi di afflusso e deflusso dal Pronto Soccorso.

Copia conforme all'originale

L'USC zonale si occupa di concordare con le Forze dell'ordine le modalità di controllo e la messa in sicurezza degli accessi al Presidio Ospedaliero S. Stefano di Prato (**Protezione Civile Prato 800301530**).

6. Fasi di attivazione del PEIMAF

FASE DI PREALLARME
Precede l'allarme vero e proprio; è comunicata dalla Centrale Operativa (CO) 118 al Medico di Pronto Soccorso (DSSH) per verificare la possibilità di attivare il piano PEIMAF in relazione alla reale recettività dell'Ospedale e del PS.

FASE DI ALLARME
Questa fase è preceduta da una fase detta di preallarme nella quale si verificano le condizioni di risposta. Vengono messi in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la massima recettività nei locali del Pronto Soccorso (PS), attraverso:

- Assegnazione e invio dei pazienti presenti nei locali PS al rispettivo livello di ricovero e appropriata assegnazione della specialistica, secondo procedura dettagliata nei tape allegati al presente documento.
- Dimissione con programma di accertamenti in post ricovero o con possibilità di rientrare per i pazienti dimissibili ancora in corso di accertamenti
- Allontanamento di tutti i pazienti con bassa priorità (cod.4 e cod.5 di triage) e relativi familiari e accompagnatori dai locali di attesa prospicienti il PS informandoli del motivo (predisposizione cartellonistica all'ingresso del PS con dicitura "Maxiemergenza in atto")

La CO 118 comunica lo stato di **PREALLARME** e successivamente dà conferma telefonica dello stato di allarme direttamente al Medico del PS che coprirà il ruolo di direttore dei soccorsi sanitari ospedalieri (DSSH); tale comunicazione deve comprendere se disponibile:

- Natura dell'evento
- Numero stimato delle vittime
- Probabile tempo stimato di arrivo
- Tipologia prevalente delle lesioni
- Altri ospedali coinvolti
- Attivazione dell'USC Aziendale e/o USC zonale.

L'allarme può arrivare attraverso due vettori:

- Telefonico ad un numero dedicato (**0574/805370**); questo telefono utilizza una linea telefonica con sistema analogico. Lo squillo telefonico ha una suoneria diversificata da tutti gli altri apparecchi telefonici e, contemporaneamente, si accende una spia luminosa.
- Radio: il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Stefano è dotato di apparato radio di tipo stanziale impostato sul canale 16 delle frequenze regionali e rispondente alla selettiva 041385. La radio è sempre in modalità on h24, ed è collegata a prese di corrente dotate di idoneo gruppo di continuità.

Il portiere, informato dalla DMPO, esegue l'annuncio con l'interfono ospedaliero: **"Attenzione maxi emergenza in atto".**

LE PROCEDURE PER ACCOGLIENZA PEIMAF DEVONO ESSERE ATTIVATE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE

Copia conforme all'originale

7. Attivazione e gestione maxi emergenza convenzionale

7.1. Catena di comando

Una volta confermata la maxi emergenza il Direttore della SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano, designa il **DSS-H.** Qualora il direttore fosse assente o non immediatamente reperibile, il ruolo del **DSS-H** viene ricoperto in ordine dal:

- Vice direttore della SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano
- Medico fuori turno PS
- Medico capoturno (flussista)o medico più esperto in maxiemergenza in turno

Le figure ed i ruoli della catena di comando da prevedere in ogni in assetto PEIMAF per una maxi emergenza convenzionale sono rappresentate nei tape SISmax (Allegato 2) e sono, inoltre, resi evidenti mediante l'utilizzo di un apposito abbigliamento (pettorine) con colori corrispondenti ai colori del bordo dei tape stessi.

La comunicazione fra le figure della catena di comando è supportata da apposita dotazione radio allocata in Controll Room e fornita dall'Area Tecnica di Presidio.
Viene comunicato alla Control Room il numero della porta d'emergenza n. **58** presente in Open Space, per provvedere a tacitazione dell'allarme.

8. Valutazione della massima capacità ricettiva e di trattamento dell'ospedale HCT (Hospital Treatment Capacity)

La valutazione delle risorse deve essere fatta in relazione allo scenario peggiore (notte e festivi) e prendendo in considerazione il personale presente in ospedale ed effettivamente reclutabile, la capacità ricettiva dovrà essere espressa in relazione al perdurare dell'emergenza (capacità immediata, a 30 minuti, nella prima ora, nelle ore successive.

Il calcolo della capacità ricettiva si basa generalmente su:

- numero totale dei posti letto dell'ospedale fruibili al momento
- numero postazioni codici maggiori in DEA
- numero sale operatorie d'urgenza con equipe completa.
- numero letti monitorizzati con possibilità di assistenza intensiva e sub intensiva
- strumentazione ecografica e radiologica convenzionale (Rx torace, Rx bacino, E -FAST) per eseguire la prima valutazione/trattamento
- immediata disponibilità di TC
- immediata disponibilità di sangue
- risorse umane: Medici (Medici d'Emergenza/Urgenza, Rianimatori, Chirurghi d'Urgenza), Infermieri di Area Critica, Radiologi, Tecnici di radiologia, OSS.

Tenendo in considerazione tutti gli elementi fin qui analizzati, nonché la riorganizzazione logistica del DEA in assetto PEIMAF, si reputa che il PO S. Stefano possa accogliere nella prima ora, durante le ore diurne al massimo 14 pazienti così suddivisi:

- **2 codici 1**
- **4 codici 2**
- **8 codici 3**

Tale stima numerica va rivista in caso di situazione di overcrowding del PS, nelle ore notturne o nei mesi estivi.

Copia conforme all'originale

9. Rimodulazione delle aree del PS/DEA in caso di PEIMAF

In assetto PEIMAF (maxi emergenza convenzionale e NBCRe) le sale del DEA verranno utilizzate nel modo seguente (Allegato 3):

- Sala rossa due postazioni
- Sala arancio 6 postazioni
- Triage interno, sala gessi, sala rosa e triage esterno: gestione dei codici minori

Tutti i pazienti ordinari presenti nell'area destinata alla maxiemergenza vengono spostati in open space e HDU, così suddivisa:

- Openspace area monitor codici 1 e 2 ordinari in arrivo
- OBI (ex HDU) pazienti già valutati che necessitano di postazione monitor
- Openspace area non monitor, corridoi paralleli, box C e box D i pazienti già valutati, stabili, che non necessitano di O_2 terapia
  Il medico di riferimento di questa area ha come postazione l'ex stanza visita medico-pediatrica.

Diagnostica per immagini:

- Radiologia del DEA dedicata ai pazienti della maxiemergenza
- Radiologia convenzionale (TAC 128) dedicata ai pazienti dell'emergenza ordinaria

Come cassa di espansione della ricezione pazienti da maxi emergenza a minor livello di intensità, viene utilizzata la Sala d'attesa del PS. Nell'area destinata alla maxiemergenza i pazienti verranno gestiti nel seguente modo:

- i codici 1e 2 in sala rossa e in sala arancio
- i codici 3 e i codici minori in triage interno, sala rosa e in sala gessi

Il triage verrà eseguito come di consueto nelle postazioni di triage interno per i pazienti barellati e di triage esterno per i pazienti che si presentano autonomamente.
La radiologia e la TC del PS sono utilizzate esclusivamente per i pazienti della maxiemergenza.

L'area dove viene gestita l'emergenza ordinaria è costituita dagli spazi:

- dell'Open Space del PS
- dell'HDU

verrà allestita una postazione di triage a livello della ex sala 1 in open space e come cassa di espansione della ricezione pazienti da emergenza ordinaria vengono utilizzati i corridoi che vanno verso l'HDU e la Psichiatria. A questo scopo viene allestito una postazione di lavoro con PC e carrello dell'emergenza nel box D.
All'attivazione dell'assetto PEIMAF tutti i pazienti ordinari presenti nell'area destinata alla maxiemergenza vengono spostati in open space e HDU.
Gli altri pazienti vengono distribuiti nelle restanti aree dell'open space, dell'HDU e, se in sovrannumero, nei corridoi che fungono da cassa di espansione se stabili e non necessitanti di ossigeno.
Queste aree usufruiscono del servizio radiologico ordinario e della TC 128 e per raggiungerlo sono trasportati attraverso il corridoio in uscita dall'HDU.

Copia conforme all'originale

10. Accesso dei Pazienti in caso di maxiemergenza convenzionale

In caso di attivazione del PEIMAF l'accesso dei pazienti deve essere diversificato in maniera che i pazienti della maxiemergenza vadano indirizzati verso l'area adibita alla maxiemergenza e quelli dell'emergenza ordinaria verso l'area dove è gestita l'emergenza ordinaria.

PEIMAF per evento convenzionale:

1. Pazienti barellati:
   a) Da maxiemergenza accesso dalla camera calda con valutazione al triage interno
   b) Da emergenza ordinaria accesso dalla porta di emergenza dell'Open Space e valutazione al triage allestito in ex stanza 1
2. Pazienti deambulanti
   a) Da maxiemergenza accesso dalla sala di attesa con valutazione al triage esterno
   b) Da emergenza ordinaria accesso dall'uscita di emergenza dell'open space e valutazione al triage allestito in ex stanza 1

Le piantine che identificano le aree di accesso al DEA/PS in caso di maxiemergenza convenzionale sono riportate nell'Allegato 3 e 4.

11. Attivazione e gestione maxi emergenza non convenzionale (NBCRe)

11.1. Catena di comando

Una volta confermata la maxi emergenza il Direttore della SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano, designa il **DSS-H.** Qualora il direttore fosse assente o non immediatamente reperibile, il ruolo del **DSS-H** viene ricoperto in odine dal:

- Vicedirettore della SOC Medicina d'Urgenza Santo Stefano
- Medico fuori turno PS
- Medico capoturno (flussista) o medico più esperto in maxiemergenza in turno

Le figure ed i ruoli della catena di comando da prevedere in assetto PEIMAF per una maxi emergenza non convenzionale (NBCRe) sono rappresentate nei tape SISmax (Allegato 2) e sono, inoltre, resi evidenti mediante l'utilizzo di un apposito abbigliamento (pettorine) con colori corrispondenti ai colori del bordo dei tape stessi.

La comunicazione fra le figure della catena di comando è supportata da apposita dotazione radio allocata in Control Room e fornita dall'Area Tecnica di Presidio.

Copia conforme all'originale

11.2. Modalità di vestizione e svestizione in caso di Maxiemergenza non convenzionale (NBCRe)

La Vestizione N.B.C.R.e.

- Rimuovere tutti gli effetti personali e indossare il sottotuta.
- Indossare la tuta partendo dal basso e portandola all'altezza dei fianchi.
- Calzare gli stivali e, se previsto dalla tuta, abbassare il copristivale.
- Inserire le braccia nelle maniche bloccando la tuta al pollice con apposita linguetta elastica.
- Indossare la tuta fino alle spalle.
- Indossare il primo paio di guanti in lattice monouso.
- Sigillare i guanti con la tuta con apposito nastro adesivo.
- Chiudere la cerniera della tuta fino a livello sternale.
- Applicare l'antiappannante alla maschera.
- Allargare al massimo le cinghie della maschera.
- Indossare la maschera senza filtro appoggiandola sul mento e passando le cinghie dietro la nuca con un unico movimento.
- Stringere le cinghie.
- Verificare la tenuta della maschera con l'apposito test.
- Calzare il cappuccio e chiudere le cerniere fino al collo.
- Sigillare la maschera alla tuta con apposito nastro.
- Indossare il secondo paio di guanti Cat 3.
- Sigillare i guanti alla tuta con apposito nastro.
- Avvitare il filtro alla maschera dopo aver tolto i sigilli.
- Controllo visivo e accesso in area Arancio.

La Svestizione N.B.C.R.e.

- Togliere il nastro dalla maschera.
- Togliere gli stivali e smaltirli in appositi contenitori.
- Togliere il nastro dai guanti Cat 3 e farli sfilare dall'operatore DECO non toccando la parte interna.
- Aprire il copricerniera e aprire fino allo sterno (operatore DECO).
- Rimuovere il cappuccio avendo cura di toccare solo l'esterno (operatore DECO).
- Sfilare la tuta fino al tronco avendo cura di toccare solo la parte esterna (operatore DECO).
- Continuare la svestizione degli arti inferiori avendo cura di toccare solo la parte interna alla tuta e avendo cura di rimanere con i piedi all'interno della stessa.
- Fare un passo in area Gialla.
- Disindossare la maschera con un unico movimento deciso all'indietro impugnandola dal filtro.
- Togliere il secondo paio di guanti.
- Smaltire tutti i D.P.I. e i rifiuti in appositi contenitori.
- Fare la doccia.

DECO PRIMARIA 5 MINUTI
DECO SECONDARIA 5 MINUTI
DECO DEAMBULANTI 5 MINUTI
DECO NON DEAMBULANTI 20 MINUTI

11.3. Stanza di decontaminazione

Presso il PO Santo Stefano è presente, con accesso separato dalla camera calda, una stanza di decontaminazione per massimo un paziente alla volta
In caso di evento NON convenzionale (NBCRe) un OSS del PS preleva **le chiavi della stanza Maxiemergenze** presente nel primo cassetto del bancone triage e si reca all'interno della stanza dove, è presente un armadio contenente le tute, le maschere il cerotto e le calzature da far utilizzare agli addetti alla decontaminazione.
Qualora il numero dei contaminati sia elevato e le operazioni di decontaminazione andasse a protrarsi nel tempo la USC Aziendale potrà attivare, a sua discrezione, attraverso la SOC Coordinamento maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario la tenda DECO che è gestita e montata dalla Protezione Civile e richiedere ulteriori DPI attraverso la stessa via.

11.4. Accesso dei pazienti in caso di maxiemergenza non convenzionale (NBCRe)

In caso di maxi emergenza non convenzionale NBCRe, si rende necessaria una modifica alle modalità di accesso al DEA dei pazienti, come da schema sotto riportato

PEIMAF per evento non convenzionale (NBCRe):

1. Pazienti barellati:
   a. Da maxiemergenza accesso dalla sala di attesa con valutazione al triage esterno
   b. Da emergenza ordinaria accesso dalla porta di emergenza dell'Open Space e valutazione al triage allestito in ex stanza 1
2. Pazienti deambulanti
   a. Da maxiemergenza accesso dalla camera calda direttamente in stanza di decontaminazione con valutazione al triage interno
   b. Da emergenza ordinaria accesso dall'uscita di emergenza dell'open space e valutazione al triage allestito in ex stanza 1

Affinché le manovre dei mezzi di soccorso possano essere più fluide possibile dovrebbe essere inoltre attivato rapidamente lo sgombro del parcheggio del PS.

Le piantine che identificano le aree di accesso al DEA in caso di maxiemergenza non convenzionale (NBCRe) sono riportate nell'Allegato 3 e 4.

12. Aree speciali

Area nera: l'area sosta salme dell'Ospedale Santo Stefano è in grado di contenere fino a 8 vittime al suo interno. Qualora il numero di vittime superasse la capienza massima dell'area sosta salme una ulteriore sala mortuaria è predisposta presso la Sala Multi culto e/o presso la Cappella debitamente presidiate.
Area informazioni parenti: l'area informazione parenti sarà attrezzata con apposite sedie e delimitata nella hall principale nella zona antistante le scale mobili. È cura del gestore (GESAT) predisporre le sedie e le delimitazioni.
La DMPO garantirà all'interno dell'area informazione parenti la presenza di personale idoneo al supporto psicologico ed eventuale altro personale di aiuto.
Area comunicati stampa: l'area comunicati stampa è allestita nella Sala del Cembalo.
Area Unità di Crisi: è allestita presso la Sala Magnolfi (situata al 1° piano della Palazzina dei Servizi) le cui chiavi sono depositate presso la Control Room **0574801354** (situata al piano terreno della Palazzina dei Servizi)

13. Reclutamento personale

In una prima fase dell'emergenza potranno essere, a cura dell'USC zonale:

Copia conforme all'originale

- Convocati presso la propria sede usuale di lavoro tutti i dipendenti in pronta disponibilità. Tale convocazione dovrà essere effettuata a cura della Direzione Infermieristica e Medica di Presidio, sulla base di elenchi nominativi già in suo possesso.
- Bloccati sul posto di lavoro tutti i dipendenti in turno smontante che si vanno a sommare ai dipendenti entranti in servizio.
- Individuati medici internisti, chirurghi ed ortopedici e rianimatori da destinare al PS. Questi medici in turno, devono prima di recarsi in PS, allertare il reperibile del proprio reparto
- Allertati ed eventualmente potenziati tutti i servizi diagnostici e le strutture di degenza specialistiche, il cui personale medico dovrà mettersi a disposizione del PS per la consulenza specialistica.
- Costituite squadre di trasporto in numero compatibile con la dimensione.
- Potenziate le dotazioni infermieristiche, nei setting di degenza, ove si preveda un notevole afflusso di feriti.

In una seconda fase dell'emergenza potranno essere fatti smontare i dipendenti trattenuti e sostituiti con dipendenti non in servizio al momento dell'emergenza.

Si sottolinea che, l'attivazione dei TSRM avviene attraverso lo specifico percorso chiamata in reperibilità dei TSRM.

14. Prolungamento e\o fine dell'emergenza

Nel caso in cui la maxiemergenza si protragga oltre la prima ora e si renda necessario attivare ulteriori spazi e risorse umane, la DMPO e la Direzione Infermieristica valutano, in sede di unità di crisi zonale, il blocco e/o la rimodulazione delle attività ordinarie con il seguente ordine:

- attività ambulatoriali e di Day Service;
- attività chirurgica programmata
- Sale Operatorie

La fine della maxi emergenza è dichiarata dalla DMPO sulla base delle notizie provenienti dal Pronto Soccorso, dal 118, dalla Prefettura e dalla Protezione Civile.

Il Direttore DMPO, in accordo al Direttore Sanitario Aziendale e al Coordinatore Aziendale Maxi-Emergenza, scioglie l'USC zonale e adotta i provvedimenti necessari a ricondurre l'operatività dell'ospedale ad una condizione di normalità.

15. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione

La diffusione del presente documento è effettuata dalla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero Santo Stefano.
La Segreteria della Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero Santo Stefano:

- conserva il frontespizio firmato e l'originale (pdf approvato della raccolta firme), con il pdf "Copia conforme all'originale" del presente documento.
- invia con modalità e–mail ai soggetti riportati nella lista di distribuzione che hanno il compito di diffonderlo, con modalità a cascata, ai collaboratori delle strutture afferenti il proprio ambito di competenza, tenuti a conoscere e ad applicare il documento.

Il presente documento è consultabile sulla Repository del Sito Intranet Aziendale e sul sito web nell'area riservata dal DEA di Prato. Inoltre, sono disponibili alcune copie cartacee sono posizionate:

- sul bancone del triage del PS
- presso la Control Room
- presso l'ufficio della segreteria amministrativa del dipartimento di emergenza

Copia conforme all'originale

16. Monitoraggio e controllo

Il presente documento è monitorato dalla struttura emittente del documento, Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero Santo Stefano e dai verificatori di processo attraverso gli indicatori di evento: vedi vigente delibera su sistema Maxiemergenza.

17. Strumenti / Registrazioni

- First Aid Web
- Scheda Triage Regione Toscana (Allegato 2 alla DOC.DS.03)

18. Revisione

Il presente documento viene revisionato ogni volta che intervengano sostanziali modifiche organizzative o eventuali variazioni nella normativa cogente o di altri documenti ufficiali presi a riferimento e comunque entro 3 anni dalla data di applicazione.

19. Allegati

- **Allegato 1 rev.1:** Elenco nominativi USC zonale
- **Allegato 2:** Tapes SISmax Ospedale
- **Allegato 3 rev.1:** Piantine di accesso al DEA in caso di maxi emergenza convenzionale e NBCRe
- **Allegato 4 rev.1:** Cartellonistica e percorsi maxiemergenza

20. Riferimenti

- Documento Aziendale "Piano Aziendale per la gestione degli eventi di Maxiemergenza" – cod. az. DOC.DS.03
- Delibera Giunta Regione Toscana n. 1390 del 27/12/2004

21. Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	26/04/2023	**PRIMA EMISSIONE**	
1	09/08/2023	**REVISIONE** Modifica: **Allegato 1:** Elenco nominativi USC zonale **Allegato 3:** Piantine di accesso al DEA in caso di maxi emergenza convenzionale e NBCRe **Allegato 4:** Cartellonistica e percorsi maxiemergenza	Piano Emergenza Intraospedaliera Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) nell'Ospedale S. Stefano di Prato

Copia conforme all'originale

22. Lista di diffusione

- Direttore Rete Ospedaliera
- Direttore SOC Coordinamento maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario
- Direttore Dipartimento Emergenza e area critica
- Direttore Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero Santo Stefano
- Direttore SOC Medicina d'urgenza Santo Stefano
- Direttore SOS Osservazione Breve Santo Stefano
- Direttore SOS Assistenza Infermieristica di Gestione Prato
- Tutti i direttori delle Strutture Organizzative del PO S. Stefano
- Tutto il personale in servizio presso il PO S. Stefano
- Gruppo di redazione

Copia conforme all'originale